

MANAJEMEN PELAYANAN YANG BAIK DENGAN KEPUASAN PASIEN YANG TINGGI

Lalu Putrama Doni
Muhammad Alwi Andi



MANAJEMEN PELAYANAN YANG BAIK DENGAN KEPUASAN PASIEN YANG TINGGI

Penulis:

Lalu Putrama Doni, S.Kep., MM.
Muhammad Alwi Andi, S.Kep., MMR.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Manajemen Pelayanan Yang Baik Dengan Kepuasan Pasien Yang Tinggi

Penulis: Lalu Putrama Doni, S.Kep., MM.
Muhammad Alwi Andi, S.Kep., MMR.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7139-74-0

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Manajemen pelayanan yang baik dengan kepuasan pasien yang tinggi / penulis, Lalu Putrama Doni, S.Kep., M.M., Muhammad Alwi Andi, S.Kep., MMR.

EDISI

Cetakan pertama, Maret 2025

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.

DESKRIPSI FISIK

80 halaman ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7139-74-0

SUBJEK

Rumah sakit, Pelayanan

KLASIFIKASI

362.11 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1187868>

PRAKATA

Puji serta syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga Monograf ini dapat tersusun. Buku monograf ini diperuntukkan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan khususnya manajemen keperawatan, Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Program Studi Administrasi Kesehatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku monograf ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga penulis bersedia menerima saran dan kritik dari berbagai pihak untuk dapat menyempurnakan monograf ini di kemudian hari. Semoga dengan adanya monograf ini dapat membantu proses belajar mengajar dengan lebih baik lagi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya sehingga buku monograf ini dapat terselesaikan dengan baik.

(Desember, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 MANAJEMEN PELAYANAN.....7

A. Pengertian Manajemen	7
B. Pentingnya Manajemen.....	10
C. Tujuan Manajemen	11
D. Pengertian Pelayanan.....	11
E. Teori Manajemen Pelayanan	12
F. Kualitas Pelayanan.....	13
G. Teori Kualitas Layanan	14
H. Konsep TQS (Total Quality Service)	16
I. Kualitas Layanan di Sektor Kesehatan	19
J. <i>Model SERVQUAL</i>	20
K. Studi Empiris tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien.....	23
L. Teknologi dan Kualitas Pelayanan.....	25
M. Dimensi Kualitas Pelayanan	27
N. Mutu Pelayanan.....	29
O. Manajemen Mutu	30
P. Manfaat Menjaga Mutu	31

BAB 3 KEPUASAN PASIEN 33

A. Pengertian Tingkat Kepuasan	33
B. Pengertian Kepuasan Pasien	34
C. Komponen Kepuasan	35

D. Tinjauan tentang Kepuasan Pasien	35
E. Teori Kepuasan Pelanggan.....	41
F. Pentingnya Kepuasan Pasien.....	41
G. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan	43
H. Metode Pengukuran Kepuasan	45
I. Survey Kepuasan Pasien.....	47
J. Manfaat Memperhatikan Kepuasan Pasien	49

BAB 4 MANAJEMEN PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN 51

BAB 5 PENUTUP..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 65

GLOSARIUM 71

PROFIL PENULIS 73

BAB 1

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kualitas layanan kesehatan semakin meningkat, terutama dalam konteks pelayanan pasien di fasilitas kesehatan. Kepuasan pasien menjadi salah satu indikator utama kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan. Fenomena ini juga dapat dilihat di Klinik Jepun, Provinsi NTB, yang merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menyediakan berbagai layanan medis kepada masyarakat. Meski Klinik Jepun telah berusaha meningkatkan kualitas layanan mereka, laporan informal menunjukkan adanya keluhan mengenai manajemen pelayanan pasien.

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan aspek krusial dalam sistem kesehatan yang dapat mempengaruhi pengalaman pasien serta hasil pengobatan. Di Indonesia, perhatian terhadap kepuasan pasien semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya pelayanan yang baik dan efektif. Kepuasan pasien tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga interaksi antara pasien dengan berbagai pihak di fasilitas kesehatan, termasuk manajer pelayanan pasien.

Kepuasan pasien tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dari pelayanan medis, tetapi juga oleh bagaimana manajer pelayanan pasien berinteraksi dan menangani kebutuhan pasien. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kepuasan pasien dengan manajer pelayanan pasien menjadi penting untuk meningkatkan kualitas layanan di klinik tersebut.

Perkembangan klinik di Indonesia sangat pesat terutama klinik yang ada di daerah Lamongan. Sejak tahun 2010 sampai 2019 terjadi penambahan jumlah klinik sebesar 26,32% (Depkes, 2015). Hal ini menimbulkan kompetisi antar klinik (Baktiar, 2019 dan Widajat, 2019). Dalam kompetisi antar klinik, kualitas pelayanan memegang peran penting (Hana, 2016). Kepuasan adalah perasaan senang seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesenangan terhadap aktivitas dan suatu produk dengan harapannya (Nursalam, 2016). Kotler (dalam Nursalam, 2017) menyebutkan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Westbrook & Reilly (dalam Tjiptono, 2017) berpendapat bahwa kepuasan pelanggan merupakan respon emosional terhadap pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang dibeli, gerai ritel, 7 atau bahkan pola perilaku (seperti perilaku berbelanja dan perilaku pembeli), serta pasar secara keseluruhan. Menurut Yamit (2016), kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang diinginkan. Sedangkan Pohan (2018) menyebutkan bahwa kepuasan pasien adalah tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya, setelah pasien membandingkan dengan apa yang diharapkannya. Pendapat lain dari Endang (dalam Mamik, 2017) bahwa kepuasan pasien merupakan evaluasi atau penilaian setelah memakai suatu pelayanan, bahwa pelayanan yang dipilih setidaknya-tidaknya memenuhi atau melebihi harapan. Kepuasan pasien merupakan perasaan senang atau kecewa yang ditimbulkan karena membandingkan kinerja yang dipersiapkan terhadap ekspektasi mereka, (Kolter, 2015).

Pada perusahaan jasa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan tercapainya tujuan perusahaan diantaranya pelayanan dan kepercayaan (trust). Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh seorang pelayan kepada pelanggan. Pelayanan yang diberikan kepada setiap pelanggan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan perusahaan. Apabila pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka akan menjamin proses pelayanan tersebut berjalan secara efisien dan pelanggan akan merasa puas. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari hasil penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan dalam bentuk barang/jasa (Suhartono, 2019). Kualitas pelayanan yang baik akan berdampak kepada kepuasan pasien, dan akan berdampak kepada niat masyarakat untuk berobat. Padma, et al (2016). Tujuan utama pelayanan yang berkualitas dari klinik adalah memahami kebutuhan dan keinginan pasien sehingga pasien puas Padma, at el., (2016). Berbagai penelitian kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien telah dilakukan (Keeler, at el., 1992; Padma, at el., 2009 dan Andaleeb, 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2019) dan Suhartono (2019) menjelaskan bahwa pelayanan prima mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepuasan adalah kepercayaan (trust) (Hamid, 1999). Kepercayaan merupakan keinginan suatu pihak untuk menjadi pasrah atau menerima tindakan dari pihak lain berdasarkan pengharapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan suatu tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memberi kepercayaan (Lendra, 2016), sehingga keberhasilan perusahaan dalam mengambil keputusan dan tindakan sangat berpengaruh kepada konsumen. Karna dari kepercayaan itu dapat membina

hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen atau pasien. Menurut Sunanti (2016), kepercayaan merupakan elemen penting yang berpengaruh pada kualitas suatu hubungan. Kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa akan meningkatkan nilai hubungan yang terjalin dengan penyedia jasa. Tingginya kepercayaan akan dapat berpengaruh terhadap menurunnya kemungkinan untuk melakukan perpindahan terhadap penyedia jasa lain.

Menurut Morgan dan Hunt (2008) aspek kepercayaan merupakan factor penting yang perlu diperhatikan dalam memenuhi harapan-harapan pasien atau sejauh mana pasien percaya terhadap keahlian yang dimiliki pihak klinik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan keyakinan pasien terhadap kredibilitas klinik, jaminan pelayanan serta niat baik dari pihak klinik. Memahami kebutuhan dan keinginan pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien merasa puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien merasa tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien, klinik harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh kepercayaan pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pasiennya (Yuwono, 2018).

Sementara itu, sejumlah studi telah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien juga memiliki dampak signifikan terhadap hasil kesehatan secara keseluruhan (Firalidi, 2023). Pasien yang merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima cenderung lebih patuh terhadap instruksi medis, memiliki tingkat pemulihan yang lebih baik, dan kurang mungkin untuk mencari pelayanan medis alternative (Dewi

lukita sari, 2020). Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien sangat penting. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan puskesmas dan kepuasan pasien. Beberapa faktor yang telah diidentifikasi melalui penelitian sebelumnya antara lain: aksesibilitas fasilitas kesehatan, kemampuan staf medis, ketersediaan fasilitas dan peralatan medis, kejelasan informasi yang disampaikan kepada pasien, interaksi antara pasien dan staf medis, waktu tunggu, dan komunikasi yang efektif (Taekab, 2019).

Konsep pemasaran dikembangkan untuk memengaruhi transaksi pertukaran yang melibatkan produk. Industri kesehatan, baik publik maupun swasta, merupakan industri jasa. Jasa memang tidak terwujud, dan tidak ada pengalihan kepemilikan yang terlibat, sebagaimana dengan pelayanan perawat terhadap pasien. Kualitas pelayanan pada era ini menjadi faktor penting dan menjadi salah satu kunci keunggulan kompetitif dalam dunia pemasaran.

Pelayanan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan semua layanan yang disediakan oleh penyedia layanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan penerima dan mematuhi peraturan perundang-undangan (Sari, 2020). Pelayanan kesehatan merupakan salah satu contoh pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab suatu negara. Layanan ini disediakan oleh para profesional kesehatan untuk mempromosikan pengembangan kesehatan yang baik untuk kualitas hidup yang lebih baik di masyarakat. Tujuan mempromosikan kesehatan yang baik dapat dicapai dengan menggunakan berbagai pendekatan yang komprehensif, hierarkis dan saling berhubungan.

BAB 2

MANAJEMEN PELAYANAN

A. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud maksud yang nyata (Hasibuan, 2009).

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu tadi. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Adapun definisi manajemen yang dijabarkan oleh beberapa ahli berikut ini seperti oleh James A.F. Stoner dan Charles Wankel (1986) dalam Siswanto (2011), yang berpendapat bahwa:

Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals, (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya, demi tercapainya tujuan organisasi).

Menurut Stoner dan Wankel, terdapat empat poin utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,

serta pengendalian dalam mewujudkan suatu manajemen yang baik, berbeda dengan Terry dan Rue dalam Syafiie (2006), yang berpendapat bahwa manajemen adalah sebagai berikut:

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "*managing*", sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola. Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah "*objective*" atau hal-hal yang nyata usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian khusus itu. Mungkin manajemen dapat digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat dilihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya "*output*" atau hasil kerja yang memadai, kepuasan manusiawi dan hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik.

Menurut Terry dan Rue dalam Syafiie (2006), ada beberapa pendekatan utama dalam manajemen, antara lain:

1. Proses Pendekatan Operasional

Manajemen dianalisa dari sudut pandang apa yang diperbuat seorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Kegiatan-kegiatan itu atau fungsi-fungsi dasar kedalam mana para manajer terlibat, membentuk suatu proses yang dinamakan proses manajemen. Pendekatan proses itu memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi dasar manajemen. Proses pendekatan itu banyak digunakan, karena ia sangat menolong dalam mengembangkan pemikiran manajemen dan membantu menentukan bentuk manajemen dalam ketentuan-ketentuan yang mudah dipahami.

2. Pendekatan Sistem Sosial

Para pendukung pendekatan ini manajemen sebagai suatu sistem sosial, atau dengan perkataan lain, sebagai suatu sistem interelasi budaya. Ia berorientasi secara sosiologis, berurusan dengan berbagai kelompok sosial dan hubungan-hubungan budayanya serta berusaha menyatukan kelompok-kelompok ini ke dalam suatu sistem sosial. Suatu organisasi dianggap sebagai sebuah organisme sosial, takluk kepada segala pertentangan dan interaksi para anggotanya. Pendekatan ini memperhitungkan kelahiran, manfaat dan fungsi suatu "organisasi informal", yang dianggap tumbuh menjadi sesuatu, terutama sekali sebagai akibat kekuatan-kekuatan sosial. Ia juga memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan etika, pengaruh masyarakat, serikat-serikat kerja dan pemerintah. Hasil bersih dari pendekatan sistem sosial adalah terbatasnya kekuatan paham sosiologis ke dalam penelitian dan teori manajemen.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian proses, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sehingga sampai pada tahap pengendalian yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga organisasi atau perusahaan tersebut dapat mencapai target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut melalui kerjasama yang baik diantara para pegawainya. Sedangkan mengarah seni adalah suatu kegiatan manajemen juga perlu mendorong orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk bisa berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru agar tercipta kehidupan organisasi

dan manajemen yang modern serta fleksibel mengikuti perkembangan zaman.

B. Pentingnya Manajemen

Dalam Hasibuan (2009), pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhannya yang terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini, maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Dalam Hasibuan (2009:3) pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan *men, money, methods, machine, materials, market* (6M) dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.

7. Manajemen mengakibatkan pencapaiantujuan secarateratur.
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang.

Manajemen sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Melalui manajemen yang baik maka pembinaan kerjasama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati dan menerapkannya demi hari esok yang lebih baik.

C. Tujuan Manajemen

Manajemen dibutuhkan padasetiap organisasi, karena tanpa manajemen semua uasaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit (Handoko, 2003). Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan;
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang bertentangan;
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

D. Pengertian Pelayanan

Secara umum pelayanan dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Pelayanan erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap

pelanggan/masyarakat. Pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang diharapkan masyarakat.

Menurut Moenir (2008:26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Groon ros (1990) dalam Ratminto dan Atik (2005) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud kan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Dari pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) sebagai interaksi antara konsumen dengan karyawan yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksud kan untuk memecahkan masalah seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konsumen/pelanggan.

E. Teori Manajemen Pelayanan

Teori Manajemen Pelayanan yang dikembangkan oleh Lovelock dan Wirtz (2016) menekankan bahwa manajer pelayanan pasien harus mengelola dan memfasilitasi pengalaman pasien secara efektif. Dalam teori ini,

keterampilan komunikasi, problem-solving, dan empati dianggap krusial untuk menciptakan interaksi yang memuaskan. Kemampuan manajer untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan memberikan informasi yang jelas dapat memperbaiki pengalaman pasien dan meningkatkan kepuasan mereka (Lovelock & Wirtz, 2016).

F. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan kesan seluruh konsumen tentang inferioritas / superioritas relatif organisasi dan layanannya (Bitner & Hubbert, 1994). Sedangkan menurut Farianita (2016) kualitas pelayanan merupakan totalitas karakteristik pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan pasien dan standar yang telah ditetapkan.

Kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda sesuai dengan persyaratan, kecocokan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala hal yang membahagiakan. Kualitas dipandang secara luas dalam perspektif TQM (Total Quality Management) yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan namun juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Goeth dan Davis dalam Tjiptono (2012) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu pelayanan yang diharapkan dan yang dirasakan (Parasuraman et al, 1985). Jika jasa yang dirasakan dan diterima sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien, maka pasien akan merasa kualitas pelayanan pada suatu pelayanan kesehatan itu baik dan memuaskan. Terdapat 5

perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas tinggi.

G. Teori Kualitas Layanan

Gronroos (1990) memperkenalkan teori Kualitas Layanan yang membedakan antara kualitas teknis dan kualitas fungsional dari layanan. Kualitas teknis merujuk pada hasil akhir dari layanan, sementara kualitas fungsional merujuk pada proses pelayanan itu sendiri. Dalam konteks klinik, kualitas fungsional sangat dipengaruhi oleh bagaimana manajer pelayanan pasien mengelola proses interaksi dan pelayanan sehari-hari (Gronroos, 1990). Manajer pelayanan yang efektif dapat meningkatkan kualitas fungsional dengan cara meningkatkan komunikasi dan responsivitas terhadap kebutuhan pasien.

Penelitian Prasetyo dan Nugroho (2019) mengkaji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pasien di klinik-klinik di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi seperti responsivitas dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Penelitian ini mendukung model SERVQUAL dengan menunjukkan bahwa aspek-aspek interaksi layanan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepuasan pasien (Prasetyo & Nugroho, 2019).

Sari (2016) dalam penelitiannya mengenai komunikasi efektif menemukan bahwa komunikasi antara pasien dan tenaga medis, termasuk manajer pelayanan, berpengaruh besar terhadap kepuasan pasien. Komunikasi yang baik membantu mengurangi ketidakpastian pasien dan

meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pelayanan yang diberikan (Sari, 2016). Hal ini sejalan dengan teori manajemen pelayanan yang menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dalam meningkatkan kepuasan pasien.

Setiawan (2018) meneliti keterampilan manajerial dan dampaknya terhadap kepuasan pasien. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterampilan seperti kemampuan menyelesaikan masalah dan empati memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Temuan ini menunjukkan bahwa keterampilan manajerial tidak hanya penting untuk efektivitas operasional tetapi juga untuk mempengaruhi persepsi dan kepuasan pasien (Setiawan, 2018).

Utami (2020) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien di klinik swasta dan menemukan bahwa manajer pelayanan berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pasien melalui pengelolaan yang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan pasien. Temuan ini mendukung teori kualitas layanan yang menekankan peran manajer dalam mempengaruhi aspek fungsional dari kualitas layanan (Utami, 2020).

Kepuasan pasien didefinisikan sebagai persepsi pasien mengenai seberapa baik pelayanan yang mereka terima dibandingkan dengan harapan mereka (Kotler & Keller, 2016). Dalam konteks penelitian ini, kepuasan pasien akan diukur berdasarkan interaksi mereka dengan manajer pelayanan pasien, serta aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi pengalaman mereka di klinik.

Manajer pelayanan pasien berperan penting dalam mengelola interaksi pasien dengan fasilitas kesehatan. Mereka bertanggung jawab untuk menangani keluhan,

memberikan informasi yang jelas, dan memastikan proses pelayanan berjalan dengan baik. Kompetensi manajer dalam hal ini, termasuk keterampilan komunikasi dan empati, sangat penting dalam menentukan tingkat kepuasan pasien (Lovelock & Wirtz, 2016).

Kualitas layanan mencakup dua aspek utama: kualitas teknis (hasil pelayanan) dan kualitas fungsional (proses pelayanan). Dalam penelitian ini, fokus akan diletakkan pada kualitas fungsional, khususnya bagaimana manajer pelayanan pasien mempengaruhi pengalaman pasien melalui interaksi mereka (Gronroos, 1990).

H. Konsep TQS (Total Quality Service)

TQS (Total Quality Service) merupakan suatu proses dimana etos komitmen pelayanan yang ditanamkan dalam perusahaan, hal tersebut dengan sendirinya akan menggerakkan usaha para karyawannya untuk terus mengembangkan serta menjaga kualitas pelayanan. TQS (Total Quality Service) memiliki tujuan untuk membangun rasa memiliki dalam memberikan pelayanan prima (Mayasari, 2016). TQS (Total

Quality Service) berfokus pada 5 aspek yaitu:

1. Fokus pada pelanggan (customer focus)
2. Keterlibatan total (total involvement)
3. Sistem pengukuran (measurement)
4. Dukungan sistematis (systematic support)
5. Perbaikan terus menerus

Untuk mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu menerapkan konsep TQS (Total Quality Service). Konsep tersebut dikembangkan guna untuk menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memuaskan

kebutuhan pasien dan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang dikembangkan untuk memperbaiki suatu kinerja atau meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan agar dapat memuaskan kebutuhan pasien (Mayasari, 2016).

Konsep TQS (Total Quality Service) dapat diukur menggunakan 7 indikator yaitu infrastruktur, kualitas staf, proses perawatan klinis, prosedur administrasi, indikator keamanan, pengalaman keseluruhan perawatan medis, dan tanggung jawab sosial (Duggirala et al., 2018).

1. Infrastruktur

Infrastruktur meliputi fitur nyata dari pemberian pelayanan kesehatan termasuk peralatan, penampilan perusahaan, fasilitas, papan nama, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya (Duggirala et al., 2018). Fasilitas tidak hanya harus menarik secara tampilan namun juga harus higienis terutama dalam pelayanan kesehatan. Sama halnya dalam model servqual yang dikemukakan oleh Parasuraman et al (1985), dalam model tersebut menggunakan benda berwujud sebagai indikator kualitas pelayanan.

2. Kualitas SDM

Kualitas SDM ini meliputi seluruh SDM yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan harapan tanggap, dapat diandalkan, ramah, tulus, dan kompeten (Duggirala et al., 2018). Sama halnya dalam model servqual yang dikemukakan oleh Parasuraman et al (1985), dalam model tersebut menggunakan indikator jaminan, empati, dan daya tanggap untuk menunjukkan kualitas SDM.

3. Proses Perawatan Klinis

Indikator ini merupakan inti dari kualitas teknis suatu pelayanan kesehatan yang diterima begitu saja oleh pasien. ketika rumah sakit gagal memberikan pelayanan, pasien tidak akan mempertimbangkan indikator lainnya meskipun staf di rumah sakit ramah pasien tidak akan menganggap layanan tersebut berkualitas tinggi (Duggirala et al., 2018).

4. Prosedur Administrasi

Prosedur administrasi rumah sakit meliputi proses penerimaan hingga pasien pulang. Berdasarkan beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa pasien merasa tidak senang jika menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk memperoleh pelayanan di rumah sakit (Duggirala et al., 2018). Administrasi yang baik dan efisien membuat pasien lebih menghargai pelayanan tersebut, dengan proses administrasi yang sesuai standar sehingga pelanggan memperoleh pelayanan dengan mudah.

5. Indikator Keamanan

Keamanan sangat penting bagi pasien karena berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar individu. Rumah sakit harus mengatasi masalah kritis keselamatan untuk memberikan pelayanan yang baik, karena pasien yang berkunjung ke rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan status kesehatannya (Duggirala et al., 2018).

6. Pengalaman Keseluruhan Perawatan Medis

Indikator ini mengukur dari pengalaman pasien terhadap pelayanan yang diperoleh di rumah sakit secara keseluruhan dan memiliki kemungkinan pasien tersebut akan merekomendasikan kepada orang lain dengan membandingkan antara pelayanan yang diperoleh dengan harapannya (Duggirala et al., 2018). Tingkat

kualitas yang dirasakan oleh pasien secara positif berhubungan dengan kepuasan pasien, kepuasan karyawan, niat untuk kunjungan ulang, dan lain sebagainya.

7. Tanggung Jawab Sosial

Indikator ini tidak terlepas pada kualitas pelayanan meskipun pada beberapa penelitian diabaikan. Pelanggan tidak hanya meminta layanan yang baik saja, tetapi juga layanan yang adil dari penyedia layanan sehingga tanggung jawab sosial merupakan indikator yang sangat penting bagi kualitas pelayanan. Indikator ini mengacu pada pelayanan yang adil, biaya pelayanan yang wajar, prinsip etika, dan menjaga privasi pasien (Duggirala et al., 2018).

I. Kualitas Layanan di Sektor Kesehatan

Kualitas pelayanan dalam sektor kesehatan dianggap sebagai elemen kritis yang secara langsung mempengaruhi pengalaman pasien dan efektivitas layanan yang diberikan. Konsep ini diperkuat oleh model kualitas pelayanan SERVQUAL, yang dikemukakan oleh yang mengidentifikasi lima dimensi utama kualitas pelayanan, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik (Sugiarto, 2021). Pertama-tama, keandalan merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan yang konsisten dan dapat diandalkan. Pasien mengharapkan penanganan yang akurat dan tepat waktu, serta kepastian bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar medis yang ditetapkan. Kedua, daya tanggap mencakup sejauh mana sistem merespons kebutuhan dan harapan pasien dengan cepat dan efisien. Kemampuan untuk memberikan perhatian yang tepat waktu terhadap keluhan, serta memberikan informasi yang

jelas dan komunikasi yang efektif, menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan pasien. Ketiga, jaminan berkaitan dengan kemampuan system kesehatan untuk menjamin kualitas pelayanan secara keseluruhan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti keamanan pasien, pemenuhan standar etika medis, dan adopsi praktik terbaik dalam pengobatan dan perawatan. Keempat, empati mencakup kemampuan staf medis untuk memahami dan merespons perasaan serta kebutuhan emosional pasien. Sikap empatik dari pihak medis dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa nyaman pasien selama proses perawatan. Terakhir, bukti fisik mengacu pada lingkungan fisik di mana layanan kesehatan diberikan. Fasilitas yang bersih, terorganisir, dan mendukung proses penyembuhan dapat meningkatkan persepsi pasien terhadap kualitas layanan yang diterima. Dalam konteks layanan kesehatan, kualitas pelayanan juga mencakup aspek keamanan pasien, di mana pencegahan kesalahan medis dan keamanan pasien menjadi fokus utama (Fristiohady, 2020). Efektivitas pengobatan, termasuk keberhasilan dalam diagnosis dan perawatan, turut menentukan tingkat kepuasan pasien. Komunikasi yang baik antara staf medis dan pasien juga menjadi unsur penting dalam menjamin kualitas pelayanan. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan dapat dimengerti oleh pasien dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan (Tumsekali, 2021).

J. Model SERVQUAL

Model SERVQUAL, yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry pada tahun 1988, telah menjadi suatu kerangka kerja yang luas digunakan untuk

mengevaluasi kualitas pelayanan di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan (Jonkisz, 2021).

Model ini memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk memahami persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan dan sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi harapan pelanggan.

1. Dimensi Model SERVQUAL

Model ini mengidentifikasi lima dimensi utama kualitas pelayanan yang relevan dalam konteks berbagai layanan, termasuk layanan kesehatan:

1) Keandalan (Reliability)

Konsistensi dan kemampuan sistem untuk memberikan layanan yang dapat diandalkan dan konsisten.

2) Daya Tanggap (Responsiveness)

Kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan efisien, merespons kebutuhan pelanggan.

3) Jaminan (Assurance)

Kemampuan memberikan kepercayaan dan jaminan terhadap kualitas pelayanan, melibatkan keamanan pasien dan profesionalisme staf medis.

4) Empati (Empathy)

Kepekaan dan kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan.

5) Bukti Fisik (Tangible)

Tampilan fisik fasilitas, peralatan, dan komunikasi visual yang mendukung pelayanan.

2. Perbandingan Persepsi dan Harapan

Model SERVQUAL mengajukan bahwa pelanggan mengevaluasi kualitas pelayanan dengan membandingkan dua dimensi, yaitu persepsi mereka terhadap layanan yang diterima dan harapan mereka

terhadap layanan tersebut. Jika persepsi pelanggan melebihi harapan, maka kualitas pelayanan dianggap baik. Sebaliknya, jika persepsi di bawah harapan, maka terdapat gap atau ketidaksesuaian yang dapat menjadi fokus perbaikan.

3. Identifikasi Gap Pelayanan

Penerapan model SERVQUAL dalam layanan kesehatan memungkinkan identifikasi gap antara harapan dan kenyataan yang dialami oleh pasien. Gap-ga ini mungkin terjadi pada setiap dimensi kualitas pelayanan dan dapat merinci area spesifik yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pasien.

4. Pengukuran dan Perbaikan Berkelanjutan

Model SERVQUAL juga menyediakan alat pengukuran kualitatif dan kuantitatif yang dapat digunakan oleh penyedia layanan kesehatan untuk memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan mereka seiring waktu. Dengan memahami gap yang ada, organisasi dapat mengambil tindakan perbaikan yang terarah untuk memenuhi dan bahkan melampaui harapan pasien.

5. Penerapan dalam Layanan Kesehatan

Dalam konteks layanan kesehatan, penerapan model SERVQUAL membantu penyedia layanan untuk lebih baik memahami kebutuhan dan ekspektasi pasien, memastikan pengalaman yang lebih memuaskan, dan secara efektif merancang strategi perbaikan berkelanjutan.

K. Studi Empiris tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien

Beberapa penelitian empiris telah secara konsisten menegaskan bahwa kualitas pelayanan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan pasien, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan secara keseluruhan, penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh Andaleeb menegaskan bahwa investasi dalam peningkatan keandalan dan daya tanggap pelayanan medis dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan kepuasan pasien. Hal ini bukan hanya berpengaruh pada persepsi positif pasien terhadap pengalaman mereka, tetapi juga dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pasien terhadap penyedia layanan kesehatan. Studi-studi semacam ini memberikan dasar yang kuat bagi penyedia layanan kesehatan untuk terus meningkatkan mutu layanan mereka dengan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang paling berpengaruh dalam menciptakan kepuasan pasien. (Amegayibor, 2023). Penelitian ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien dan tingkat kepuasan yang mereka alami (Rombon, 2020). Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa dua dimensi kualitas pelayanan kesehatan, yaitu keandalan dan daya tanggap, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan pasien.

1. Keandalan

Keandalan pelayanan medis mencakup konsistensi dan dapat diandalkannya pelayanan yang diberikan oleh sistem kesehatan. Pasien menginginkan jaminan bahwa prosedur medis, diagnosis, dan perawatan yang mereka terima bersifat konsisten dan dapat diandalkan. Penelitian Andaleeb menyoroti bahwa ketika pasien merasakan

keandalan dalam setiap aspek perawatan, hal ini secara positif memengaruhi tingkat kepuasan mereka. Keandalan memberikan keyakinan kepada pasien bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar tinggi dan dapat diandalkan.

2. Daya Tanggap

Daya tanggap pelayanan medis berkaitan dengan kemampuan sistem kesehatan untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan dan harapan pasien. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasien cenderung lebih puas ketika mereka merasakan bahwa staf medis dan fasilitas kesehatan secara efisien merespons permintaan, pertanyaan, atau kekhawatiran mereka. Daya tanggap yang baik menciptakan pengalaman pasien yang lebih positif dan dapat meningkatkan persepsi mereka terhadap kualitas layanan secara keseluruhan.

3. Implikasi dalam Pelayanan Kesehatan

Temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merancang strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan. Menyadari bahwa keandalan dan daya tanggap memiliki dampak positif terhadap kepuasan pasien, penyedia layanan kesehatan dapat memprioritaskan upaya untuk meningkatkan aspek-aspek ini dalam praktek mereka.

Secara keseluruhan, penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh Andaleeb menegaskan bahwa investasi dalam peningkatan keandalan dan daya tanggap pelayanan medis dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan kepuasan pasien. Hal ini bukan hanya berpengaruh pada persepsi positif pasien terhadap pengalaman mereka, tetapi juga dapat membangun

kepercayaan dan loyalitas pasien terhadap penyedia layanan kesehatan. Studi-studi semacam ini memberikan dasar yang kuat bagi penyedia layanan kesehatan untuk terus meningkatkan mutu layanan mereka dengan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang paling berpengaruh dalam menciptakan kepuasan pasien.

L. Teknologi dan Kualitas Pelayanan

Penelitian empiris yang dilakukan dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan secara konsisten menyoroti hubungan erat antara kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Hasil-hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman kita tentang dinamika kompleks dalam interaksi antara penyedia layanan dan pasien, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi kepuasan pasien yang menyoroti peran penting keandalan dan daya tanggap dalam membangun kepuasan pasien.

1. Keandalan Pelayanan Medis

Keandalan dalam konteks pelayanan medis mencakup kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan yang konsisten, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian Andaleeb mengungkapkan bahwa keandalan ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Ketika pasien merasa bahwa pelayanan yang mereka terima konsisten dari waktu ke waktu, ini menciptakan rasa percaya dan keyakinan pada penyedia layanan kesehatan. Keandalan menjadi kunci dalam membangun fondasi kepercayaan, yang pada gilirannya, menjadi landasan kepuasan pasien.

2. Daya Tanggap Pelayanan Medis

Daya tanggap pelayanan medis melibatkan kemampuan sistem kesehatan untuk merespons dengan cepat dan efisien terhadap kebutuhan dan harapan pasien. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat daya tanggap yang tinggi dari staf medis dan fasilitas kesehatan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien. Ketika pasien merasa didengar, mendapat perhatian yang cepat, dan mendapatkan solusi yang efisien terhadap masalah atau kebutuhan mereka, hal ini menciptakan pengalaman positif yang memperkuat persepsi mereka terhadap kualitas layanan secara keseluruhan.

3. Implikasi Praktis

Temuan-temuan ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi penyedia layanan kesehatan. Mengetahui bahwa keandalan dan daya tanggap berperan besar dalam meningkatkan kepuasan pasien, penyedia layanan dapat menitikberatkan upaya-upaya mereka pada meningkatkan konsistensi layanan dan merespons dengan baik terhadap kebutuhan pasien. Ini mungkin melibatkan perbaikan dalam sistem administratif, komunikasi antar-staf, dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan interpersonal.

4. Pentingnya Berlanjutnya Penelitian

Meskipun penelitian Andaleeb memberikan wawasan yang berharga, penting untuk dicatat bahwa konteks pelayanan kesehatan terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami perubahan dalam harapan dan preferensi pasien serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor baru yang mungkin mempengaruhi kepuasan pasien di era yang terus berubah ini.

M. Dimensi Kualitas Pelayanan

Kepuasan pelanggan dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut Zeithaml (2013), dimensi-dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan terdiri dari tangible, reliable, responsiveness, security, competence, courtesy, credibility, acces, dan communication. Dimensi-dimensi tersebut menjadi ukuran untuk menilai kualitas pelayanan, terutama dimensi tangible, reliabel, responsiveness, assurance dan empathy.

Tangible adalah penampilan fisik yang terdiri atas sarana atau fasilitas fisik, perlengkapan atau peralatan, kerapian dan penampilan pegawai atau personil, sarana komunikasi, dan sebagainya. Courtesy merupakan sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pasien serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.

Reliable (kehandalan) adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Kehandalan mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Kehandalan terdiri atas kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang disajikan dengan tepat.

Responsiveness (daya tanggap) adalah kemauan untuk membantu pasien bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Daya tanggap merupakan kemampuan para petugas untuk membantu para pasien dalam memberikan pelayanan yang tepat. Competence merupakan tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan.

Credibility merupakan sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan pasien. Acces adalah kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.

Assurance (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para petugas, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Security merupakan jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko.

Emphaty (empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pasien.

Communication adalah kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pasien, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada pasien. Understanding the Customer adalah segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pasien.

Sunyoto (2012) menyatakan kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai atau guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan.

Menurut Wahyudiyono (2021), Kualitas pelayanan merupakan penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh yang dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Sedangkan Tjiptono (Indrasari, 2019), mendefinisikan kualitas pelayanan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaian agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut.

Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. Salah satu cara untuk mempertahankan sebuah perusahaan jasa adalah memberikan jasa dengan kualitas pelayanan yang lebih tinggi dari pesaing secara konsisten dan memenuhi harapan pelanggan.

N. Mutu Pelayanan

Mutu atau kualitas menurut Goetsh dan Davis (1994) dalam Irine Diana Sari (2010) adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Mutu atau kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen (Dening). Suatu produk dikatakan bermutu apabila dapat memberikan kepuasan, sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen (Feigen Baum), *conformance to requirement*, sesuai dengan yang distandarkan (Crosby), *customer oriented* (Martinich, 1997).

Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi (Azhrul Aswar, 1996).

Mutu pelayanan kesehatan adalah memenuhi dan melebihi kebutuhan serta harapan pelanggan melalui peningkatan yang berkelanjutan atas seluruh proses. Pelanggan meliputi pasien, keluarga dan lainnya yang datang untuk mendapatkan pelayanan dokter, karyawan (Mery R. Zimmerman). Secara umum pengertian mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan secara normal, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah, serta masyarakat konsumen (Purwoastuti, 2015).

O. Manajemen Mutu

Hansen dan Mowen (2009:17) mengemukakan bahwa TQM adalah suatu perbaikan berkelanjutan yang mana hal ini adalah sesuatu yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna. Memproduksi produk dan pengurangan pemborosan yang sesuai dengan standar merupakan dua tujuan umum perusahaan. Filosofi dari manajemen mutu sebenarnya yaitu dimana sebuah perusahaan berusaha menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan pekerjaannya menghasilkan produk atau jasa yang sempurna (zero-defect), dan mencoba memperbaiki kesalahan dimasa lalu. Penekanan pada kualitas juga telah menciptakan kebutuhan akan adanya suatu system akuntansi manajemen yang menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan tentang kualitas.

Manajemen mutu juga diterjemahkan sebagai pendekatan berorientasi pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematis dan perbaikan terus menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses manajemen mutu memiliki input yang spesifik (keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan), mentransformasi (memproses) input dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada pelanggan (output). Tujuan

utama total quality management adalah perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus (Natha, 2008:4).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu merupakan sebuah pendekatan yang menekankan peningkatan proses produksi secara terus menerus melalui eliminasi pemborosan, peningkatan kualitas, serta mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, tujuan akhir dari konsep manajemen mutu adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dan upaya mengurangi suatu kesalahan/ketidaksempurnaan barang atau jasa yang dihasilkan.

P. Manfaat Menjaga Mutu

Program menjaga mutu dapat dilaksanakan, sehingga banyak manfaat yang akan diperoleh. Secara umum beberapa manfaat yang dimaksudkan adalah:

1. Dapat lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan.

Peningkatan efektifitas yang dimaksud di sini erat hubungannya dengan dapat diselesaikannya masalah yang tepat dengan cara penyelesaian masalah yang benar. Karna dengan diselenggarakannya program menjaga mutu dapat diharapkan pemilihan masalah telah dilakukan secara tepat serta pemilihan dan pelaksanaan cara penyelesaian masalah telah dilakukan secara benar.

2. Dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

Peningkatan efisiensi yang dimaksudkan disini erat hubungannya dengan dapat dicegahnya penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan atau yang dibawah standar. Biaya tambahan karena pelayanan yang berlebihan atau karna harus mengatasi beberapa efek

samping karna pelayanan yang di bawah standar akan dapat dicegah.

3. Dapat lebih meningkatkan penerimaan pelayanan terhadap pelayanan kesehatan.

Peningkatan penerimaan ini erat hubungannya dengan telah sesuai pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuturan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan.

Apabila peningkatan pemerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperan besar dalam turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dapat melindungi pelaksanaan pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum.

BAB 3

KEPUASAN PASIEN

A. Pengertian Tingkat Kepuasan

Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. Kepuasan merupakan tingkatan di mana kinerja anggapan produk sesuai dengan ekspektasi pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan sangat puas (Kotler dalam Intani, 2016). Menurut Pohan dalam Aggrianni, 2017 pengertian kepuasan pasien adalah harapan pasien yang timbul atas tindakan tenaga kesehatan sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan selama proses berinteraksi dalam upaya memberikan pelayanan. Menurut

Menurut Abdullah (2012) kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang, puas dengan pelayanan dikarenakan sesuai dengan apa yang pelanggan harapkan.

Tingkat Kepuasan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara harapan dan pengalaman dari kinerja penyedia jasa. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi. Sehingga harapan berarti sesuatu yang diinginkan agar dapat terjadi, dengan

demikian harapan menyangkut masa depan. Sedangkan kinerja adalah pandangan terhadap pelayanan yang telah diterima konsumen (Prawitasari & Tatrisona, 2006).

B. Pengertian Kepuasan Pasien

Menurut William dan Torrens (1980), kepuasan pasien adalah suatu ukuran yang merefleksikan output dan struktur pelayanan. Kepuasan yang dipandang sebagai konsep multidimensional yang melibatkan biaya, sarana/kemudahan, aspek teknis dan hubungan interpersonal antara asuhan dengan output dari asuhan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kepuasan dapat dinilai dari episode spesifik, asuhan pribadi pasien dan asuhan kesehatan secara umum.

Menurut Kotler 1997, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.

Kepuasan adalah salah satu hasil pelayanan kesehatan. Kepuasan penggunaan pelayanan kesehatan mempunyai kaitan dengan hasil pelayanan kesehatan yang penting, baik secara medis maupun ekonomis seperti kepatuhan terhadap pengobatan, pemahaman terhadap informasi medis dan kelangsungan perawatan. (Jacobalis, 1989).

Menurut (Heathfield, 2019) kepuasan pasien adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apakah karyawan bahagia dan terpenuhi keinginan dan kebutuhan mereka di tempat kerja. Banyak pengujian menyatakan bahwa kepuasan pasien adalah faktor dalam motivasi karyawan, pencapaian tujuan karyawan, dan moral karyawan yang positif di tempat kerja. Faktor penting dengan

kepuasan pasien adalah bahwa karyawan yang puas harus melakukan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang dibutuhkan perusahaan.

C. Komponen Kepuasan

Stephen Strasser dan Rose Marie dalam bukunya *Measuring Patient Satisfaction for Improved Patient Services* mendefinisikan kepuasan pasien terdiri dari empat komponen yaitu stimuli, value judgement, reaction, individual differences. Secara konsep, kepuasan pasien merupakan nilai pendapat pasien yang khas dan reaksi berikutnya terhadap pendorong (stimuli) yang mereka rasakan dilingkungan perawatan kesehatan baik sebelum, selama dan sesudah pada kunjungan mereka. Nilai pendapat dan reaksi ini akan dipengaruhi oleh karakteristik watak dari pasien dan kehidupan sebelumnya dan pengalaman mereka mendapatkan perawatan kesehatan. Jadi kepuasan pasien merupakan reaksi dalam menanggapi pendorong (stimuli) dan nilai pendapat yang dibatasi oleh karakteristik watak.

D. Tinjauan tentang Kepuasan Pasien

Mutu pelayanan sangat subyektif, tergantung persepsi, sistem nilai dan latar belakang sosial, pendidikan ekonomi, budaya dan faktor-faktor lainnya. Bagi pasien, mutu pelayanan yang baik dikaitkan dengan kesembuhan dari penyakit, meningkatnya derajat kesehatan/kesegaran, kecepatan pelayanan, kepuasan terhadap lingkungan fisik dan tarif yang dianggap memadai. Mutu pelayanan yang buruk lebih disebabkan oleh perawat yang bermuka cemberut betapapun cekatan dan profesionalnya perawat tersebut dalam memberikan pelayanan (Jacobalis, 1989).

Menurut Lovelock (1998) dalam Jacobalis, persepsi pelanggan (pasien) tentang mutu pelayanan merupakan perbandingan antara harapan sebelum dan sesudah mereka menerima asuhan yang sebenarnya. Dengan kata lain mutu pelayanan dinilai apakah memenuhi harapan pasien atau tidak. Apabila harapan terpenuhi hal itu dirasakan tidak memuaskan. Jika harapan dipenuhi melampaui espektasi, mutu dirasakan sebagai sangat memuaskan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gronroo (1988) di Eropa (Jacobalis, 1989).

Pendapat Lethinen yang dikutip oleh Lovelock (1988) mengatakan bahwa persepsi mutu pelayanan berasal dari proses pelayanan maupun mutu hasil akhir (output) pelayanan, dimana mutu proses pelayanan selama pelayanan tersebut berlangsung dan mutu hasil akhir akan dinilai setelah pelayanan berakhir. (Jacobalis, 1989). Engel, dkk dalam Thiptono dan Diana (2001), menyatakan kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan. Dalam Tjiptono (2001), mengatakan bahwa kepuasan adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaiannya.

Menurut Kotler 1997, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Beberapa teori yang berkaitan dengan kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management (dalam: Djoko Wijono, 1999) memberikan definisi tentang

kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) kepuasan adalah tingkat keadaan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Dengan demikian tingkat kepuasan adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dan harapan. Ada tiga tingkat kepuasan:

- a. Bila penampilan kurang dari harapan, pelanggan tidak dipuaskan;
 - b. Bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan puas;
 - c. Bila penampilan melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.
2. Stephen Strasser dan Rose Marie dalam bukunya *Measuring Patient Satisfaction for Improved Patient Services* mendefinisikan kepuasan pasien terdiri dari empat komponen yaitu *stimuli*, *value judgement*, *reaction*, *individual differences*. Secara konsep, kepuasan pasien merupakan nilai pendapat pasien yang khas dan reaksi berikutnya terhadap pendorong (*stimuli*) yang mereka rasakan dilingkungan perawatan kesehatan baik sebelum, selama dan sesudah pada kunjungan mereka. Nilai pendapat dan reaksi ini akan dipengaruhi oleh karakteristik watak dari pasien dan kehidupan sebelumnya dan pengalaman mereka mendapatkan perawatan kesehatan. Jadi kepuasan pasien merupakan reaksi dalam menanggapi pendorong (*stimuli*) dan nilai pendapat yang dibatasi oleh karakteristik watak.
3. Menurut Kotler dan Roberto (1989) dalam Jacobalis, ada 5 macam tuntutan atau harapan calon pasien terhadap personal pemberi pelayanan, yaitu:

- a. Responsif: harus bersedia dan siap melayani cepat, dan mengatur pelayanan dengan cepat.
- b. Kompeten: harus mengetahui tugasnya apa dan bagaimana melaksanakannya.
- c. Kesopanan: ramah tamah, hormat, beretiket baik, sopan dan fleksibel.
- d. Kredibilitas: dapat dipercaya dan jujur.
- e. Sensitivitas: mengerti akan kebutuhan pasien memberikan perhatian kepada pasien dan peka terhadap lingkungan.

Selain itu, terdapat harapan calon pasien tentang tempat perawatan adalah sebagai berikut:

- a. Akses (*access*): waktu yang sesuai, tempat yang cocok.
- b. Keamanan: aman dan *privacy*.
- c. Penampilan: fasilitas yang secara fisik dan menarik.

Dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible, konsumen umumnya menggunakan lima atribut/faktor dimensi kepuasan pelanggan (Parasuraman, et al 1985 dalam Tjiptono, 1997) yaitu sebagai berikut:

- a. Keandalan (*reliability*) yaitu elemen yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan pelayanan yang dapat diandalkan dan dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan kesehatan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
- b. Jaminan (*assurance*) yaitu elemen yang berhubungan dengan kemampuan untuk merebut kepercayaan dan keyakinan klien yang didasari oleh pengetahuan, kesopanan petugas serta sifat yang dapat dipercaya sehingga terbebas dari resiko.
- c. Bukti langsung (*tangible*) bukti yaitu sesuatu yang tampak meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, peralatan, Pasien dan sarana komunikasi. Termasuk kebersihan

dan nyaman ruangan rumah sakit, tempat parkir yang luas dan aman, kerapian penampilan Pasien, kelengkapan peralatan kedokteran dan sebagainya.

- d. Empati (*emphaty*) yaitu elemen yang berkaitan dengan rasa peduli untuk memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan serta kemudahan untuk dihubungi.
- e. Ketanggapan (*responsiveness*) yaitu kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik. Elemen yang berkaitan dengan kesediaan pasien dalam membantu dan memberikan layanan yang terbaik bagi klien, yang meliputi pasien cepat tanggap terhadap informasi yang jelas, pasien dapat melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan bermakna serta menyelesaikan dengan baik.

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi instansi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi masing-masing, maka untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan Kepmenpan No 25 2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang "relevan, valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

- b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

E. Teori Kepuasan Pelanggan

Teori kepuasan pelanggan banyak dipengaruhi oleh model *SERVQUAL* yang diperkenalkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988). Model ini mengidentifikasi lima dimensi kualitas layanan tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (responsivitas), assurance (jaminan), dan empathy (empati) yang berperan penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. Dalam konteks layanan kesehatan, termasuk di klinik-klinik seperti Klinik Jepun, dimensi-dimensi ini membantu menilai kualitas interaksi antara pasien dan staf medis, termasuk manajer pelayanan pasien (Parasuraman et al., 1988).

Menurut model *SERVQUAL*, kepuasan pasien dapat meningkat jika layanan memenuhi atau melebihi harapan mereka pada kelima dimensi tersebut. Misalnya, responsivitas dari manajer pelayanan pasien dalam menanggapi keluhan atau permintaan pasien dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mereka (Lovelock & Wirtz, 2016).

F. Pentingnya Kepuasan Pasien

Kepuasan pasien bukan hanya sekadar tanggapan subjektif terhadap layanan kesehatan; sebaliknya, itu diakui sebagai indikator utama kualitas layanan dalam konteks pelayanan kesehatan. Pentingnya hubungan antara tingkat kepuasan pasien dengan berbagai aspek perilaku dan keputusan pasien terkait perawatan kesehatan. Pasien yang merasa puas dengan pelayanan kesehatan cenderung

membentuk hubungan yang lebih baik dengan penyedia layanan. Hubungan yang positif ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan saling percaya antara pasien dan staf medis. Kepercayaan ini, pada gilirannya, dapat memperkuat komunikasi antara kedua belah pihak, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik terkait kondisi kesehatan pasien. Selain itu, pasien yang puas memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mematuhi perawatan yang direkomendasikan (Rikumahu, 2024). Mereka lebih mungkin mengikuti petunjuk medis, menjalani tes yang dianjurkan, dan mengambil obat sesuai dengan resep dokter. Kepatuhan ini menjadi kritis dalam meningkatkan efektivitas perawatan dan hasil kesehatan jangka panjang. Tingkat kepuasan pasien juga memiliki dampak signifikan terhadap kemungkinan merekomendasikan layanan kesehatan kepada orang lain. Pasien yang merasa puas dengan pengalaman mereka lebih cenderung memberikan rekomendasi positif kepada teman, keluarga, atau rekan mereka. Dengan adanya rekomendasi ini, rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan dapat memperoleh reputasi yang baik dalam masyarakat, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga tersebut. Selanjutnya, kepuasan pasien juga berpengaruh pada keputusan pasien untuk kembali menggunakan layanan yang sama di masa depan. Pasien yang merasa puas memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memilih kembali penyedia layanan yang telah memberikan pengalaman positif. Ini menciptakan hubungan jangka panjang antara pasien dan lembaga kesehatan, yang dapat berujung pada pelayanan yang berkelanjutan dan pemeliharaan kesehatan yang efektif (Shi, 2020).

G. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terdiri dari factor internal dan factor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu sendiri, diantaranya adalah karakteristik individu, faktor sosial dan faktor emosional dan faktor kebudayaan. Faktor eksternal terdiri dari karakteristik produk, sarana atau fasilitas, harga, lokasi, pelayanan, image atau reputasi, desain, suasana, komunikasi dan sebagainya.

Karakteristik Individu meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kebutuhan seseorang terhadap suatu barang atau jasa akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Kebutuhan terhadap pelayanan kuratif atau pengobatan semakin meningkat saat usia mulai meningkat dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan preventif atau pencegahan. Tingginya angka kesakitan pada perempuan daripada angka kesakitan pada laki-laki menyebabkan perempuan membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih banyak.

Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran akan status kesehatan dan konsekuensinya untuk menggunakan pelayanan kesehatan. Perbedaan tingkat pendidikan akan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pekerjaan juga akan mempengaruhi status ekonomi seseorang. Seseorang yang berpenghasilan diatas rata-rata mempunyai minat yang lebih tinggi dalam memilih pelayanan kesehatan.

Secara sosial, interaksi seseorang dengan orang lain akan mempengaruhi seseorang dalam memilih pelayanan kesehatan, seperti mendapatkan saran dari keluarga atau teman dalam memilih pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Seseorang yang telah yakin bahwa orang lain puas pada pelayanan yang dipilih, maka orang tersebut cenderung memiliki keyakinan yang sama.

Pengalaman dari orang lain terhadap pelayanan kesehatan akan berpengaruh pada pendapatnya dalam hal yang sama. Perilaku pasien sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan kebudayaan yang mereka miliki, sehingga pemberi pelayanan kesehatan harus memahami peran pasien tersebut.

Faktor eksternal seperti karakteristik produk berupa pelayanan kesehatan secara fisik, kebersihan ruang perawatan serta kelengkapannya juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pasien akan merasa puas dengan kebersihan ruangan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Sarana dan prasarana harus diperhatikan dalam memberikan fasilitas yang baik terhadap pasien. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat pasien dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Harga memiliki peran penting dalam menentukan kepuasan pasien, karena pasien cenderung memiliki harapan bahwa semakin mahal biaya pelayanan kesehatan maka semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan. Bentuk pelayanan juga harus kompeten dan memperhatikan kebutuhan pasien dan menghargai pasien. Pelayanan yang memberikan kesan baik akan meningkatkan kepuasan pasien.

Lokasi atau jarak pelayanan kesehatan, letak kamar, dan lingkungan akan mempengaruhi kepuasan pelayanan kesehatan. Pasien akan mempertimbangkan jarak dari tempat tinggal pasien ke lokasi pelayanan kesehatan, transportasi yang menjangkau pelayanan kesehatan dan lingkungan pelayanan kesehatan yang baik.

Image atau reputasi pelayanan kesehatan merupakan hasil interpretasi dan penilaian dari pasien. Pasien akan menerima dan memberikan informasi tentang pelayanan yang pernah ia terima. Informasi yang bersifat positif akan memberikan citra positif bagi pelayanan kesehatan tersebut. Dalam hal desain visual, pasien yang menjalani perawatan membutuhkan rasa nyaman saat berada di ruang perawatan. Ruangan yang memberikan rasa nyaman harus memperhatikan tata ruang dekorasi yang indah. Pasien merasa puas apabila mendapat kenyamanan saat menjalani perawatan.

Suasana pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman akan memberikan kesan positif bagi pasien yang berkunjung. Tidak hanya kenyamanan suasana secara fisik, namun suasana keakraban antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan akan mempengaruhi kepuasan pasien.

Komunikasi pemberi layanan kesehatan kepada pasien membuat interaksi keduanya berjalan baik. Setiap keluhan pasien harus cepat diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan agar pasien merasa dipedulikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan hal ini akan memunculkan kesan positif bagi pelayanan kesehatan tersebut.

H. Metode Pengukuran Kepuasan

Menurut Kolter (2005), terdapat beberapa metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan yaitu sistem keluhan dan saran, *gost shopping*, *lost customer analysis*, dan *survey kepuasan pelanggan*. Sistem keluhan dan saran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan ataupun saran. Organisasi yang berorientasi pelanggan (*customer centered*) memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk

menyampaikan saran dan keluhan, kartu, komentar, costemer hot lines, dan lain-lain.

Ghost shopping merupakan salah satu cara untuk memperoleh gambaran kepuasan pelanggan atau pasien dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pembeli, selanjutnya melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing. Lost customer analysis dilakukan dengan menghubungi pelanggan yang berhenti berlangganan dan memahami mengapa hal tersebut terjadi. Peningkatan lost customer rate menunjukkan kegagalan perusahaan untuk memuaskan pelanggan.

Survey kepuasan pelanggan adalah melakukan survei untuk memperoleh umpan balik ataupun tanggapan secara langsung dari pelanggan. Pengukuran kepuasan melalui metode ini dapat dilakukan dengan cara directly reported satisfaction, derived satisfaction, problem analysis, importance-performance analysis dan sebagainya.

Directly reported satisfaction adalah menanyakan tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan perusahaan baik secara khusus, akan di peroleh jawaban seperti sangat tidak puas, tidak puas, biasa saja, puas, sangat puas. Derived statisfaction adalah meminta pelanggan untuk menilai pelayanan saat ini kepada mereka dan bagaimana seharusnya pelayanan mereka perlu diubah atau diperbaiki.

Problem analysis adalah meminta pelanggan mengungkapkan masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan produk atau jasa yang diberikan perusahaan serta meminta saran-saran mereka untuk perbaikan. Importance performace analysis adalah menanyakan kepada pelanggan mengenai tingkat kepuasan tiap pelayanan dan bagaimana perusahaan menyajikan tiap layanan tersebut.

I. Survey Kepuasan Pasien

Untuk mengetahui kepuasan pasien dapat dilakukan dengan survey yang bertujuan untuk memperoleh umpan balik ataupun tanggapan secara langsung dari pelanggan. Survey yang dimaksudkan untuk mengukur kepuasan pelanggan dapat dilakukan antara lain dengan *directly reported satisfaction*. Cara ini dilakukan dengan menanyakan tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan perusahaan baik secara khusus, akan di peroleh jawaban seperti sangat tidak puas, tidak puas, biasa saja, puas, sangat puas dan sebagainya.

Untuk menanyakan kepuasan pelanggan dengan *directly reported satisfaction* hendaknya disusun kuesioner yang akan disebarkan kepada para pasien. Dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan pasien tersebut berbentuk pernyataan yang terdiri dari item-item tentang penampilan fisik (*tangibles*), kehandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Setiap pernyataan dalam kuesioner disediakan jawaban secara berjenjang dari jawaban tidak puas, kurang puas, puas dan sangat puas.

Penilaian *tangible* (penampilan fisik) ditujukan kepada peralatan yang modern, fasilitas yang terlihat menarik, pekerja berpenampilan yang rapih dan professional serta unsur pendukung yang terlihat baik. Contoh penilaian penampilan fisik: Petugas pendaftaran mengenakan pakaian yang rapi, tersedia toilet yang bersih, terdapat ruang bermain anak, dokter bersikap ramah, dokter berpakaian rapi, petugas Farmasi berpakaian rapi dan sebagainya.

Penilaian *reliable* (kehandalan) ditujukan kepada pelayanan yang memberi bentuk pelayanan seperti yang

dijanjikan, pelayanan kepada pelanggan dapat diandalkan, memberikan pelayanan dengan segera, memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dan menjaga catatan bebas dari kesalahan. Contoh penilaian kehandalan: Alat penunjang (mesin nomor antrian) berfungsi dengan baik, alur pendaftaran sudah jelas, terdapat papan petunjuk poliklinik, dokter menjelaskan hasil pemeriksaan secara jelas yang mudah dimengerti pasien, pengeras suara pemanggilan di unit farmasi berfungsi dengan baik, dan sebagainya.

Penilaian responsiveness (daya tanggap) ditujukan kepada pelayanan yang selalu memberikan informasi kepada pelanggan tentang kapan pelayanan siap diberikan, pelayanan terhadap pelanggan diberikan dengan tanggap, kemauan untuk membantu pelanggan dan kesiapan untuk menanggapi permintaan pelanggan. Contoh penilaian daya tanggap: Informasi yang diberikan petugas pendaftaran mudah dimengerti, terdapat antrian prioritas pada pendaftaran, tersedia kursi tunggu prioritas, tersedia security yang memberikan informasi yang dibutuhkan, ruang pemeriksaan bersifat privasi dan sebagainya.

Penilaian assurance (jaminan) ditujukan kepada pelayanan pekerja dapat menanamkan kepercayaan dalam diri pelanggan, membuat pelanggan merasa aman saat melakukan transaksi, pekerja selalu menunjukkan sikap sopan santun dan pekerja memiliki pengetahuan luas untuk menjawab pertanyaan pelanggan.

Penilaian empathy (empati) ditujukan kepada pelayanan yang memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, pekerja melayani pelanggan dengan penuh perhatian, pekerja mengutamakan kebutuhan pelanggan, pekerja memahami kebutuhan pelanggan dan

mempunyai jam kerja yang sesuai. Contoh penilaian jaminan: Waktu pendaftaran cepat, dokter datang sesuai dengan jam pelayanan, petugas menjelaskan informasi mengenai dosis, efek samping dan cara penyimpanan obat secara jelas dan mudah dimengerti, dan sebagainya.

J. Manfaat Memperhatikan Kepuasan Pasien

Di dalam situasi Rumah Sakit banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh bila mengutamakan kepuasan pasien, karena pasien adalah klien yang terbanyak. Manfaat tersebut adalah (Fais Satrianegara, 2014):

1. Rekomendasi medis untuk kesembuhan pasien akan dengan senang hati diikuti oleh pasien yang merasa puas terhadap pelayanan rumah sakit.
2. Terciptanya citra positif dan nama baik rumah sakit karena pasien yang puas tersebut akan memberitahukan kepuasannya kepada orang lain. Hal ini menguntungkan rumah sakit karena termasuk pemasaran yang tidak langsung.
3. Citra rumah sakit akan menguntungkan secara sosial dan ekonomi karena jumlah pasien yang meningkat untuk berobat dan ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan seperti apa yang mereka dengar dari orang lain maupun berita.
4. Berbagai pihak yang berkepentingan seperti asuransi akan mudah mempercayai rumah sakit yang memiliki citra positif.
5. Di dalam rumah sakit yang berusaha mewujudkan kepuasan pasien akan diwarnai dengan situasi pelayanan yang menjunjung hak-hak pasien. Rumah sakit pun berusaha sedemikian rupa sehingga malpraktik tidak terjadi.

Dalam Izza (2021) internal service quality adalah kemampuan operasional melalui penggunaan pilihan strategis kedalam serangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam institusi oleh pihak manajemen kepada pegawai atau unit institusi yang mampu, berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan eksternal. Internal service quality merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk memberikan pelayanan internal kepada karyawan untuk meningkatkan kepuasan pasien sehingga dapat berdampak terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen.

BAB 4

MANAJEMEN PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepuasan pasien dan kinerja manajer pelayanan pasien. Hasil ini sejalan dengan teori *SERVQUAL* yang menyatakan bahwa kualitas layanan yang baik, termasuk kinerja manajer, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan (Parasuraman et al., 1988). Kinerja manajer yang baik dalam hal responsivitas dan empati berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Prasetyo dan Nugroho (2019) yang menemukan bahwa dimensi responsivitas dan empati mempengaruhi kepuasan pasien secara signifikan.

Penilaian tinggi pada dimensi *Responsiveness* menunjukkan bahwa pasien merasa manajer pelayanan cepat dalam menanggapi kebutuhan mereka, sedangkan penilaian rendah pada *Assurance* menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam hal memastikan kepercayaan pasien terhadap kemampuan manajer. Temuan ini sejalan dengan Setiawan (2018) yang menekankan pentingnya keterampilan manajerial dalam mempengaruhi kepuasan pasien. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eninirkhayatun dkk (2017) yang menyatakan bahwa jaminan (*assurance*) memengaruhi kepuasan pasien. Informasi yang disampaikan oleh dokter dan perawat secara jelas, dan juga keahlian dan ketarampilan dokter dan perawat dapat meningkatkan kepuasan pasien yang sedang menjalani rawat inap. Saat pasien merasa mendapat jaminan

atau kepastian atas pelayanan kesehatan yang didapatkannya ia hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepuasan pasien. Penelitian lainnya oleh Yusuf dkk (2021) juga menyatakan bahwa jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pasien yang sedang menjalani perawatan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan pada dimensi jaminan mayoritas berada didalam kategori puasdimana hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan kesehatan pada dimensi jaminan sudah memuaskan dan telah sesuai antara harapan dan keinginan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pihak klinik harus dapat mempertahankan kualitas pelayanan pada dimensi jaminan agar tetap menjaga tingkat kepuasan pasien rawat inap klinik.

Dokter dan pasien memiliki perspektif yang sangat berbeda pada faktor-faktor yang dipandang sebagai hal paling mendasar dalam komunikasi antara dokter dengan pasien. Suatu penelitian sederhana meminta para dokter dan pasien untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang dokter yang baik. Para dokter menyatakan bahwa kemampuan diagnosis merupakan kualitas yang paling penting dari seorang dokter yang baik, sedangkan pasien mengatakan bahwa mendengarkan ialah aspek yang paling penting. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Delamothe yang mengemukakan tiga kategori pandangan yang paling memengaruhi pilihan pasien untuk kategori dokter yang baik yaitu dokter yang berkomunikasi dengan pasien dan menunjukkan sikap peduli, menjelaskan prosedur medis atau teknis dengan cara yang mudah dipahami, dan mendengarkan serta meluangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi *Empathy* mendapat penilaian tertinggi, yang menunjukkan bahwa pasien merasa diperhatikan dan dipahami oleh manajer pelayanan. Ini

mendukung temuan Sari (2016) yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan empati dalam meningkatkan kepuasan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter dan perawat telah memberikan perhatian kepada pasien selama pemeriksaan atau selama menjalani rawat inap. Selain itu dokter dan perawat juga bersikap sopan dan ramah kepada pasien serta cenderung untuk tidak membedakan pasien yang datang ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Namun, perawat dan dokter lebih dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mengurangi kecenderungan untuk membedakan pasien yang menginginkan untuk memperoleh perawatan kesehatan sehingga kepuasan pasien dapat lebih ditingkatkan kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasien berada dalam kategori tinggi yaitu dengan artian bahwa pasien merasa puas atas pelayanan kesehatan yang didapatkannya berdasarkan dimensi perhatian. Pasien mendapat perhatian penuh baik dari dokter maupun perawat selama menjalani rawat inap di klinik.

Peningkatan perhatian hingga tidak membedakan pasien berdasarkan status sosial harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar klinik tetap mendapatkan kepercayaan dari pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Dengan meningkatkan dimensi perhatian, pasien yang menjalani rawat inap di klinik akan merasakan energi positif karena mendapat perhatian lebih dari dokter ataupun perawat.

Peningkatan itu bisa dilakukan dengan melakukan 3S yaitu senyum, sapa, sentuh. Hal tersebut membangun kepercayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien hingga dapat mempercepat proses pemulihan dari pasien rawat inap.

Sebaliknya, dimensi *Tangibles* mendapat penilaian terendah, menunjukkan bahwa fasilitas fisik klinik belum

sepenuhnya memenuhi ekspektasi pasien, yang mungkin mempengaruhi keseluruhan pengalaman pasien selama dirawat.

Analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan pasien dan kinerja manajer pelayanan pasien ($r = 0,68$; $p < 0,01$). Hal ini berarti semakin baik kinerja manajer pelayanan pasien, semakin tinggi kepuasan pasien.

Kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan juga merupakan variabel kritis. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang tinggi dapat membangun kepercayaan pasien, yang pada gilirannya, dapat memperkuat hubungan antara penyedia layanan dan pasien (Anjayati, 2021).

Berdasarkan penilaian masyarakat yang berkaitan dengan kehandalan pegawai dalam melaksanakan kerjanya telah efektif karena mampu memberikan layanan yang cukup baik sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan terpenuhi. dalam pengukuran mutu pelayanan kesehatan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan standar pelayanan minimum yang tiap pelayanannya menggunakan standar yang sudah ditetapkan (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006). Untuk mengetahui mutu pelayanan, Rumah Sakit melakukan survey kepuasan pasien. Dan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus selalu tepat waktu dan menangani sesuai dengan apa yang pelanggan butuhkan. Termasuk ketepatan waktu dokter umum maupun spesialis dalam melakukan penanganan kesehatan terhadap pelanggannya (Hartono, 2010).

Daya tanggap atau Responsiveness dalam memberikan pelayanan kesehatan berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan kepada

pelanggannya (Ulumiyah, 2018). Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik dengan petugas selalu standby di tempat dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengantri dengan senyum, salam, sapa, sopan santun. Dan dalam melakukan tindakan pengobatan dokter selalu menanyakan keluhan pasien terlebih dahulu sebelum pasiennya bertanya mengenai keluhannya (Anfal, A.L, 2020).

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa kenyamanan, keberadaan pegawai atau petugas serta sarana-sarana penunjang atau pelengkap pelayanan yang ada akan turut menentukan baik atau buruknya kualitas pelayanan. Sehingga faktor image dan sarana pendukung dari Rumah Sakit mampu menjadi penilaian baik dan buruknya kualitas yang dimiliki (Daryanto dan Setyobudi Ismanto, 2014).

Bukti fisik dalam pelayanan kesehatan meliputi sarana prasarana yang ada dalam penyedia jasa pelayanan kesehatan dan juga performa Sumber Daya Alamnya (Hajrah, 2022). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Noviana (2017) yang menyatakan bahwa bukti fisik (tangible) memengaruhi kepuasan pasien saat menjalani rawat inap. Hal ini juga sesuai dengan penelitian lainnya oleh Imelda dkk (2017) yang menyatakan bahwa bukti fisik masih menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan agar sesuai dengan harapan yang diinginkan klien dan menimbulkan rasa percaya atas keberhasilan manajemen klinik dalam meningkatkan kepuasan pasien.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan gedung ataupun kelengkapan teknologi yang dimiliki Klinik yang sudah cukup lengkap. Ruang rawat inap juga telah memiliki tempat tidur yang nyaman dan bersih. Dalam hal

kerapihan, perawat telah memenuhi harapan yang diinginkan oleh pasien sehingga menimbulkan kepuasan. Namun dalam hal penyediaan teknologi diharapkan bahwa klinik masih mampu untuk meningkatkan kembali perlengkapan medis agar lebih canggih dan memadai sehingga peningkatan kepuasan pasien pada variabel bukti fisik dapat ditingkatkan dengan melakukan pembaruan terhadap perlengkapan medis yang saat ini dimiliki klinik. Dengan peningkatan pada dimensi bukti fisik seperti kelayakan gedung, kerapihan perawat atau dokter hingga perlengkapan dan kecanggihan teknologi akan menambah nilai positif dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik.

Jaminan dalam hal ini petugas mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap perusahaan dan bisa menciptakan rasa aman bagi pelanggannya. Ketepatan waktu sesuai jadwal merupakan salah satu hal yang akan menjadi tolak ukur kepercayaan yang dirasakan oleh pelanggan, sehingga apabila kepercayaan telah diperoleh dari pelanggan maka akan meningkatkan nilai kualitas dari pelayanan itu sendiri (Hardiyansyah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara bahwa perawat dan dokter berhati-hati dalam memberikan tindakan terhadap pelanggan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan untuk mengurangi hal tersebut Rumah Sakit melakukan supervisi yang dilakukan setiap hari, dan apabila terdapat petugas yang kurang berhati-hati atau menyalahi aturan meskipun tidak fatal maka petugas tersebut diberi nilai min dan mendapat teguran oleh supervisor tersebut. Dengan ini maka rumah sakit perlu ditingkatkan lagi mengenai ketertiban dalam mentaati peraturan agar tidak terjadi hal yang merugikan orang lain meskipun itu tidak fatal.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2020) yang menyatakan bahwa perhatian secara positif memengaruhi kepuasan pasien. Sebagai penerima layanan kesehatan, pasien mengharapkan pelayanan kesehatan yang dapat sesuai dengan harapan mereka sehingga akan menimbulkan kepuasan saat mendapatkan perawatan di klinik tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Imelda dkk (2015) yang mengatakan bahwa perhatian juga merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi agar kepuasan pasien dapat tercapai.

Jumlah kunjungan keseluruhan dan jumlah kunjungan pasien lama membutuhkan suatu analisis untuk mengetahui perilaku pasien dalam menentukan keputusannya. Hal tersebut karena upaya mempertahankan pasien lama merupakan aset yang sangat berharga bagi rumah sakit. Guna mempertahankan keberadaan pasien, rumah sakit membutuhkan peran perawat sebagai tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien.

Manusia merupakan makhluk yang terus menerus memiliki keinginan apabila kebutuhan tertentu terpenuhi maka kebutuhan lain muncul. Manusia secara terus menerus melakukan usaha-usaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang akan berhubungan dengan perilaku pasien yang pada dasarnya merupakan konsumen jasa pelayanan kesehatan. Kepuasan bagi pasien ialah jika perawat banyak senyum, ramah, terampil dan cepat dalam penanganan, agar pasien nyaman dan tenang. Pasien secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan suatu kegiatan. Kepuasan pasien tidak cukup dengan meningkatkan fasilitas lingkungan fisik. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada pasien yang

terutama yaitu proses interaksi antara petugas dengan pasien dalam pelayanan kesehatan. Interaksi antara petugas dengan pasien merupakan hal sangat mendalam yang dirasakan pasien saat menerima pelayanan terutama saat mereka sangat memerlukan pertolongan. Proses interaksi ini dipengaruhi oleh perilaku petugas dalam melaksanakan pelayanan termasuk keramahmatan, kecakapan, ketanggapan perhatian, komunikasi, kecepatan melayani dan lain-lain.

Mutu pelayanan kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai pemenuhan kebutuhan serta harapan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Semakin meningkat tuntutan dan kebutuhan pasien, maka semakin meningkat mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Pelayanan yang dirasakan oleh pasien akan dibandingkan dengan harapannya, yang disebut kepuasan pasien, yaitu perasaan puas pasien setelah membandingkan kinerja dari Medical Scope Journal (MSJ), Volume 4, Nomor 2, pelayanan kesehatan yang terima dengan harapannya. Kualitas mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Kepuasan pasien tergantung pada kualitas mutu pelayanan yang diberikan di RS, dan kualitas mutu pelayanan akan memberikan suatu dorongan kepada pasien untuk dapat mempercayai suatu pelayanan yang diberikan sehingga dapat terjalin hubungan kuat antara pasien dengan RS. Jika mutu pelayanan kesehatan diabaikan, hal ini akan berdampak pada jumlah pasien sebab pasien tidak percaya dan berbalik ke RS lain yang dianggap memenuhi harapannya.

Petugas memahami apa yang dirasakan pelanggan dan mampu menanggapi apa yang pelanggan butuhkan serta melebihi harapannya maka akan menimbulkan kepuasan dan berakibat kepada loyalitas dalam penggunaan jasa pelayanan

kesehatan (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006). Sehingga masyarakat akan mampu merasakan pelayanan yang memuaskan dari pemberi pelayanan. Secara singkat penilaian masyarakat terhadap sumber daya manusia pemberi pelayanan (service people) dalam memberikan pelayanan kesehatan (Hardiyansyah, 2018).

Kolaborasi antar rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama, merupakan bagian penting dari konstruksi kewibawaan. Tim dapat menggabungkan upaya mereka, memaksimalkan kekuatan dan keahlian masing-masing anggota, dan menciptakan sinergi yang kuat dengan kerja tim yang kuat. Ketika rekan kerja bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi informasi, mereka dapat membangun tempat kerja yang positif dan bermanfaat. Karyawan merasakan manfaat langsung dari hal ini. Disiplin kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kerjasama tim.

Organisasi mampu mencapai tujuan program kerja yang ada berkat kedisiplinan pegawai. Pengembangan manajemen sumber daya manusia juga sangat bergantung pada etos kerja. Sopiah (2018) mendefinisikan kerja tim sebagai kelompok yang upaya individunya lebih memotivasi daripada jumlah kontribusinya.

Melalui upaya yang terkoordinasi, kerjasama tim menghasilkan sinergi yang positif. Upaya individu mereka menghasilkan tingkat motivasi yang lebih tinggi dibandingkan jumlah kontribusi individu mereka. Dapat disimpulkan dari definisi sebelumnya bahwa motivasi tim dalam suatu organisasi atau bisnis lebih unggul daripada motivasi individu (Saragih, 2020) Kesimpulan tersebut sejalan dengan temuan Purwanto, Bachri, dan Arifin (2022): interaksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qin (2024), R &

Santhiya (2024), dan Sivasankaran & Kannan (2024), yang menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja. Dampak dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dipimpin oleh Geomanda et al., (2024); Lathifan dan Suherman, (2023); Mursidah, (2023) menunjukkan bahwa korespondensi mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap eksekusi.

BAB 5

PENUTUP

Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pelayanan lingkungan dan fasilitas yang tersedia. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit maka diharapkan semakin memuaskan pasien sebagai penerima layanan, meskipun pada dasarnya kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan merupakan nilai subjektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dan diterima oleh pasien. Meskipun nilai subjektif ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor akan tetapi kepuasan pasien tetap akan didasari oleh kebenaran dan kenyataan objektif yang dialami oleh pasien saat menerima pelayanan di rumah sakit. Kepuasan merupakan pernyataan psikologi yang dihasilkan dari terpenuhi atau tidaknya harapan dengan pelayanan yang diterima secara nyata.

Kepuasan pasien merupakan suatu sikap. Walaupun hal ini belum bisa membuat pasien untuk tetap loyal kepada dokter atau rumah sakit, tetapi hal ini merupakan faktor penting. Kepuasan pasien adalah salah satu indikator dak langsung terhadap kualitas dokter atau rumah sakit. Pelayanan terhadap pasien yang disediakan harus dengan sepenuh hati, bukan kadang-kadang tapi selalu. Sehingga hal ini dapat diterapkan kepada setiap pasien setiap waktu.

Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pelayanan (medis, keperawatan, gizi, laboratorium, radiologi, administrasi), lingkungan dan fasilitas yang tersedia. Pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pengguna jasa

pelayanan, lingkungan Rumah Sakit yang tenang dan nyaman serta ketersediaan fasilitas yang memadai akan membuat pasien mengungkapkan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Ukuran yang bisa digunakan jika pasien dianggap puas dengan pelayanan yang diberikan adalah jika pasien tersebut akan kembali memanfaatkan layanan yang diberikan. Dari sisi petugas, mutu pelayanan berarti keleluasaan dalam melakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Penyedia jasa (pelayanan kesehatan) harus memperhatikan standar mutu pelayanan yang lebih baik dengan memperhatikan kriteria mutu yang ditetapkan oleh konsumen, jika fokusnya pada pengembangan pelayanan yang ditujukan untuk menjamin kepuasan konsumen sebagai pelanggan. Akan tetapi jika pengembangan mutu ingin memperhatikan mengenai biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh konsumen melalui lembaga asuransi sebagai efisiensi dan pelayanan kesehatan lebih terjangkau tanpa mengorbankan efektivitas pelayanan yaitu kesembuhan pasien, maka kegiatan pelayanan kesehatan akan mampu menjamin kepuasan konsumen dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat dan tidak bertentangan dengan standar operasional prosedur medis dan keperawatan baku serta tidak melanggar kode etik profesi.

Seperti halnya hukum ekonomi apabila pelayanan kesehatan memenuhi harapan pasien, maka pasien akan mengulang kembali untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif bermakna antara kepuasan pasien dengan minat kunjung kembali (nilai $p = 0,000$, $D_+ = 0,05$). Penelitian Churchill dan Suprenant menunjukkan bahwa minat dan perilaku konsumen untuk membeli atau memakai jasa dari

pemberi jasa yang sama sangat dipengaruhi oleh pengalaman terhadap pelayanan yang diberikan sebelumnya.

Kepuasan konsumen akan keseluruhan pelayanan akan positif dan besar pengaruhnya terhadap minatnya untuk berperilaku menggunakan jasa yang sama, apabila konsumen merasakan pelayanan dengan kualitas yang tinggi yaitu pelayanan yang didapat sama atau lebih tinggi dari yang diharapkan. Perilaku seseorang yang mengulang kembali pelayanan yang telah di rasakannya menunjukkan adanya suatu tanggapan yang dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, pengetahuan tentang cara memanfaatkan suatu keadaan untuk mencapai tujuan. Selain itu, pola perilaku masyarakat dalam kultur masyarakat Jawa individu (sakit) dalam pengambilan keputusan untuk menentukan akses pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh keluarga, struktur gaya hidup, fisik, lingkungan sosial , pola perilaku serta oleh kepercayaan mengenai keberhasilan pelayanan tersebut di samping jenis dan frekuensi penyakit.

Meskipun demikian mutu pelayanan kesehatan harus diutamakan, karena seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mendorong berpikir kritis terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa akan menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu.

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan pasien. Kepuasan diukur dari tingkat kepuasan rata-rata pasien serta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Perilaku merupakan hasil yang positif atau negatif dari suatu tanggapan atau proses belajar yang dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, pengalaman masa lalu, dan kesadaran mengetahui cara memanfaatkan suatu keadaan untuk mencapai

tujuan. Sikap, keyakinan dan persepsi seseorang terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh tujuan perilaku itu sendiri. Kepuasan pasien lebih ditentukan oleh hubungan interpersonal daripada kualitas proses dari suatu pelayanan.

Kepuasan merupakan perbandingan antara kualitas jasa pelayanan yang didapat dengan keinginan, kebutuhan dan harapan. Kepuasan pasien berhubungan dengan mutu pelayanan kesehatan. Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien atau pelanggan.

Dimensi kehandalan pelayanan ialah dimensi kualitas pelayanan yang berupa kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai janji yang ditawarkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan akurat. Pada diagram Kartesius, tiga dari kelima item tersebut termasuk dalam kuadran A (prioritas utama). Ketiga item tersebut ialah petugas kesehatan handal dalam memberikan tindakan saat memeriksa pasien, dokter melakukan pendataan riwayat kesehatan pasien, dan dokter memberikan penjelasan tentang pencegahan masalah kesehatan yang diderita pasien. Kurangnya penyampaian informasi tentang cara memelihara kesehatan, pola hidup bersih dan sehat serta pencegahan masalah kesehatan yang terkait dengan kondisi pasien dikarenakan waktu untuk konsultasi pasien terbatas, terutama pada puskesmas dengan jumlah kunjungan pasien per hari yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, N. I. (2023). The influence of training, discipline, and innovation on the performance of members of the Regional National Crafts Council (Dekranasda) in Tanjungpinang City: A quantitative study. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 53-70.
- AKOB, M. Y. (2021). Element of marketing: SERVQUAL toward patient loyalty in the private hospital sector. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 419-430.
- Amegayibor, G. K. (2023). Government Covid-19 Stimulus Package, Smes' Awareness, Accessibility, and Challenges in Cape Coast. *International Journal of Accounting and Management Information Systems*, 1(1), 67-80.
- Anjayati, S. (2021). Review Artikel: Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Menggunakan Metode Servqual. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 1(1), 31-38.
- Arikunto, S. (1995). Manajemen Penelitian. Edisi Revisi III. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, A. (1996). Pengarang Administrasi Kesehatan. Edisi Ketiga. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Bamidele AR, Hoque ME, Van der Heever H. (2011). Patient satisfaction and factor of importance in primary health care services in Botswana. *Afr J Biomed Res*. 14(1):1-7.
- Bentler, P.M., & Speckart, G. (1979). Models of Attitude – Behavior Relation Psychology Review. *Universi ty Cal i fornia. Los Angeles*. ;86(5):452-64.
- Bowers, M.S., Swan, J.E., & Koehlor, W.F. (1994). What Attribute Determine Qual i ty and Satisfaction with Health Care Delivery. *Health Care Management Review*. Aspen

Publisher Inc.;4:49-55.

- Churchil and Suprenant. (1982). An Investigation in to Determinant of Customer Satisfaction, *Journal of Marketing Research* 19 (November):491-504.
- Dewi lukita sari, A. (2020). Pengaruh Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pendaftaran Rawat Jalan Puskesmas Sayegan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Setya Medika*, 5, 1–15.
- Donabedian, A. (1980). The Definition of Quality and Approach to its Measurement. *Health Administration*, Ann Arbor, MI.
- Engel, J.F., Blackwell, R.D., & Miniard, P.W. (1993). *Consumer Behavior*. Sixth Edition. The Dryden Press, Chicago.
- Firaldi, Y. W. (2023). The influence of leadership, discipline, and workload on employee performance through job satisfaction as an intervening variable in Regional Revenue Agency Riau Islands Province. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 27-52.
- Fristiohady, A. F. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Puuwatu Kota Kendari menggunakan Metode SERVQUAL. *Jurnal Surya Medika*, 6(1), 6–12.
- Garner, P., Thomson, J., & Donaldson, D. (1990). *Quality Assessment of Health Facilities in Rural Papua New Guinea*. Oxford University Press ; 5(1):49-59.
- Gillson, L., Alilo, M., & Heggenhougen, K. (1994). Community satisfaction with Primary Health Care Services: an Evaluation Undertaken in The Morogoro Region of Tanzania. *Elsiver Scien Ltd, Freat Britain* ;39 (6): 767-80.
- Smet, B. *Psikologi Kesehatan*.
- Hafizzurrachman. (2004). Pengukuran Kepuasan Suatu Institusi Kesehatan, *Majalah Kedokteran Indonesia* ;54(7):282-8.

- Hooker. Roderick.S., Potts Ron., Ray Wendy., (1997). Patient Satisfaction Comparing Physician Assistants Nurse Practitioners and Physicians, *The Permanent Journal*, Summer.;1(1).
- Irfan SM, AamirIjaz, Farooq MM. (2012). Patient satisfaction and service quality of public hospitals in Pakistan: an empirical assessment. *Middle-East Journal of Scientific Research*.
- Indrasari, M. (2019). *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press.
- Jonkisz, A. K. (2021). SERVQUAL method as an “old new” tool for improving the quality of medical services: A literature review. *International journal of environmental research and publichealth*, 18(20), 10758.
- Kotler, P., Andreasen, A. R. (1995). *Strategi Pemasaran Untuk Organisasi Nirlaba*. Terjemahan Emelia O.M. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Manajemen Pemasaran Jilid 1 edisi II. Jakarta:Gramedia
- Kuntjoro, T. (1996). *Modul Manajemen Mutu Terpadu*. Program Pascasarjana. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jurusan Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lupiyo R, Hamdani A. (2009). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat
- Mernawati D, Zainafree I. (2016). Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. *Public Health Perspective Journal*.
- Muninjaya. (2004). *Manajemen Kesehatan, Buku Kedokteran EGC*, Jakarta.

- Novanda, R. R. (2023). International Journal of Accounting and Management Information Systems. *Promotion Effectiveness of Small Scale Enterprises (SMEs) in Indonesian Unicorn Marketplace*, 1(1), 33-44.
- Rikumahu, B. (2024). Comparison of Black-Scholes Models Using Historical Volatility and Garch Volatility in Collar Strategy as Hedging Efforts for Tawr and Tbig Stocks. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(2), 129-148.
- Robbins, S. (1996). Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi Aplikasi., Jilid I. Ed. Bahasa Indonesia. PT. Prehalindo, Jakarta.
- Rombon, L. A. (2020). Kepuasan Pasien Di Puskesmas Papakelan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat UNIMA*, 02(02), 2-7.
- Sastroasmoro, S. dan Ismael, S. (1995). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Setyawati A. (2018). Hubungan mutu pelayanan terhadap minat memanfaatkan kembali pelayanan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit TK. IV Madiun. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*. 14(2):41-7.
- Shi, Z. &. (2020). A review on quality of service and servqual model. In *HCI in Business, Government and Organizations: 7th International Conference, HCIBGO 2020*.
- Sibai, M. T. (2021). Service Quality and Student Satisfaction Using ServQual Model: A Study of a Private Medical College in Saudi Arabia. *International Education Studies*, 14(6), 51-58.
- Solikhah, (2006). Studi kepuasan Pasien Rawat Inap di Puskesmas Panggang II Gunungkidul Yogyakarta., *Jurnal Kesmas. Yogyakarta* ;1(1):39-43.
- Sugiarto, S. &. (2021). Service Quality (SERVQUAL) Dimensions

- on Customer Satisfaction: Empirical Evidence from Bank Study. *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, 1(2), 93-106.
- Sunyoto. (2012). Manajemen Pemasaran .Edisi Ke 2. Jakarta: Erlangga.
- Supriyanto, Ernawaty M. (2010). Pemasaran Industri Jasa Kesehatan. Yogyakarta: Andi.
- Taekab, A. H. (2019). Analisis Persepsi Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Puskesmas Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang Tahun 2018. *Jkm, Volume 7*, 31–40.
- Tjiptono F. (2003). Total Quality Management, Penerbit Andi, Yogyakarta,;415.
- Tumsekali, E. A. (2021). Interval valued intuitionistic fuzzy AHP-WASPAS based public transportation service quality evaluation by a new extension of SERVQUAL Model: PSERVQUAL 4.0. . *Expert Systems with Applications*, 186, 115757.
- Utami, S., Suparmi., Indarjati, A., dan Mildawani, M. (1994). Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wahyudiyono. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik Terhadap Loyalitas Pelanggan “Buka Lapak” Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Di Kampus Ama Yogyakarta). *Jurnal Solusi*, Volume 16 No 1, 39-51
- Walker, D. (1997). Mendahulukan Pelanggan. Terjemahan Adiwiyanto, A., Binarupa Aksara, Jakarta.
- Wijono. (2016) Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga.
- Wirmando, Astari AM, Yuliatun L. (2020). Nurses’ experience of caring for criminals at emergency department. *Malaysian Journal of Nursing (MJN)*. 12(1):57-62.

- Wowor J, Rumayar AA, Maramis FRR. (2019). Hubungan antara mutu jasa pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit Cantia Tanposo Baru. Jurnal KESMAS. 8(6):560-6.
- Zarei E, Daneshkohan A, Pouragha B, Marzban S, Arab M. (2015). An empirical study of the impact of service quality on patient satisfaction in private hospitals, Iran. Glob J Health Sci.
- Zeithaml, V.A., M.J. Bitner, D.D. Gremler. (2013). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm 6th ed. Mc.Graw-Hill. Boston

GLOSARIUM

A

AAA: adalah

B

BBB: adalah

C

CCC: adalah

PROFIL PENULIS



Lalu Putrama Doni, S.Kep., MM adalah seorang dosen yang telah ditempuh pendidikan S1 pada Program Studi Keperawatan di STIKES Yarasi Mataram tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Mataram. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 penulis memulai karir sebagai seorang pengajar di SPK pada waktu itu, yang sekarang menjadi SMK Yarsi Mataram. Saat ini penulis bekerja di STIKES Kusuma Bangsa dan mengajar di Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan publikasi.



(Muhammad Alwi Andi, S.Kep., MMR) Lahir di Jenggik, 21 Maret 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 di STIKES Yarsi Mataram sebagai Dosen. Saat ini penulis bekerja di STIKES Kusuma Bangsa mengampu mata kuliah Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alwycisse@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan aspek krusial dalam sistem kesehatan yang dapat mempengaruhi pengalaman pasien serta hasil pengobatan. Di Indonesia, perhatian terhadap kepuasan pasien semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya pelayanan yang baik dan efektif. Kepuasan pasien tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga interaksi antara pasien dengan berbagai pihak di fasilitas kesehatan, termasuk manajer pelayanan pasien.

Kepuasan pasien tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dari pelayanan medis, tetapi juga oleh bagaimana manajer pelayanan pasien berinteraksi dan menangani kebutuhan pasien. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kepuasan pasien dengan manajer pelayanan pasien menjadi penting untuk meningkatkan kualitas layanan di klinik tersebut.

Kepuasan pasien merupakan suatu sikap. Walaupun hal ini belum bisa membuat pasien untuk tetap loyal kepada dokter atau rumah sakit, tetapi hal ini merupakan faktor penting. Kepuasan pasien adalah salah satu indikator langsung terhadap kualitas dokter atau rumah sakit. Pelayanan terhadap pasien yang disediakan harus dengan sepenuh hati, bukan kadang-kadang tapi selalu. Sehingga hal ini dapat diterapkan kepada setiap pasien setiap waktu.

Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pelayanan (medis, keperawatan, gizi, laboratorium, radiologi, administrasi), lingkungan dan fasilitas yang tersedia. Pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pengguna jasa pelayanan, lingkungan. Penyedia jasa (pelayanan kesehatan) harus memperhatikan standar mutu pelayanan yang lebih baik dengan memperhatikan kriteria mutu yang ditetapkan oleh konsumen, jika fokusnya pada pengembangan pelayanan yang ditujukan untuk menjamin kepuasan konsumen sebagai pelanggan.

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan aspek krusial dalam sistem kesehatan yang dapat mempengaruhi pengalaman pasien serta hasil pengobatan. Di Indonesia, perhatian terhadap kepuasan pasien semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya pelayanan yang baik dan efektif. Kepuasan pasien tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga interaksi antara pasien dengan berbagai pihak di fasilitas kesehatan, termasuk manajer pelayanan pasien.

Kepuasan pasien tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dari pelayanan medis, tetapi juga oleh bagaimana manajer pelayanan pasien berinteraksi dan menangani kebutuhan pasien. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kepuasan pasien dengan manajer pelayanan pasien menjadi penting untuk meningkatkan kualitas layanan di klinik tersebut.

Kepuasan pasien merupakan suatu sikap. Walaupun hal ini belum bisa membuat pasien untuk tetap loyal kepada dokter atau rumah sakit, tetapi hal ini merupakan faktor penting. Kepuasan pasien adalah salah satu indikator langsung terhadap kualitas dokter atau rumah sakit. Pelayanan terhadap pasien yang disediakan harus dengan sepenuh hati, bukan kadang-kadang tapi selalu. Sehingga hal ini dapat diterapkan kepada setiap pasien setiap waktu.

Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pelayanan (medis, keperawatan, gizi, laboratorium, radiologi, administrasi), lingkungan dan fasilitas yang tersedia. Pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pengguna jasa pelayanan, lingkungan. Penyedia jasa (pelayanan kesehatan) harus memperhatikan standar mutu pelayanan yang lebih baik dengan memperhatikan kriteria mutu yang ditetapkan oleh konsumen, jika fokusnya pada pengembangan pelayanan yang ditujukan untuk menjamin kepuasan konsumen sebagai pelanggan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-74-0



9

786347

139740